

CRISIS MIASTÉNICA

Antía Reguera Acuña, Gemma María González Velasco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Descompensación grave en un paciente con diagnóstico de miastenia grave (MG). Representa un empeoramiento rápido de la debilidad que puede poner en riesgo la vida por potencial compromiso de la vía aérea por disfunción ventilatoria o bulbar. Se produce debilidad de la musculatura respiratoria que precisa soporte ventilatorio.

Desencadenantes

- Infecciones (lo más frecuente, sobre todo respiratorias y urinarias).
- Fármacos: corticoides u otros.
- Cirugía reciente.
- Cambios en la medicación: defecto de la medicación anticolinesterásica, descenso rápido de tratamiento inmunosupresor.
- Estrés.

DIAGNÓSTICO

Datos clínicos

- Empeoramiento de la debilidad de extremidades varios días antes.
- Diplopía.
- Debilidad bulbar: voz nasal, disartria, disfagia, mal manejo de secreciones.
- Disnea.

Exploración física

- Ptosis palpebral.
- Incapacidad para el mantenimiento de la mirada hacia arriba.
- Debilidad facial bilateral.
- Debilidad mandibular.
- Disartria flácida.
- Fatigabilidad y debilidad marcada en extremidades.

Datos sugestivos de fallo respiratorio de origen neuromuscular:

- Taquipnea, taquicardia, diaforesis, discurso entrecortado.
- Incapacidad de contar de 1 a 20 en una única respiración (capacidad vital reducida).
- Debilidad para la flexión del cuello (se relaciona con compromiso de la fuerza del diafragma).
- Respiración paradójica (hundimiento de la pared abdominal durante la inspiración por debilidad diafragmática).

Pruebas complementarias

- Hemograma con fórmula y recuento leucocitarios.
- Bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), creatincinasa (CK). PCR.
- Coagulación básica si toma de anticoagulantes orales.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
- ECG.
- Gasometría arterial si SatO₂ < 94% y clínica respiratoria.

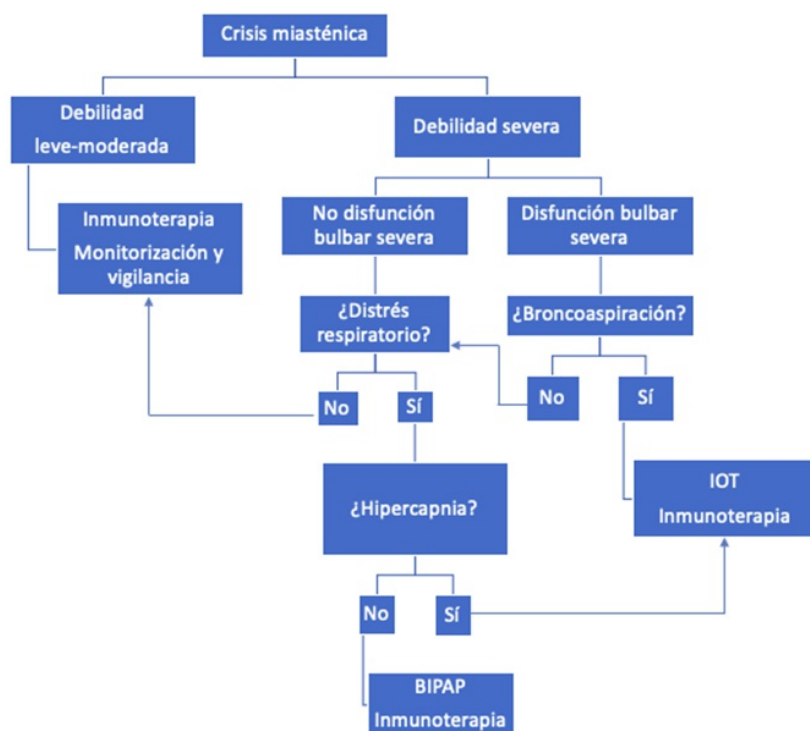
Diagnóstico diferencial

- Crisis colinérgica: por exceso de medicación anticolinesterásica pueden incrementar la debilidad: miosis (tamaño pupilar <2 mm), salivación excesiva, aumento de secreciones bronquiales, sudoración, bradicardia y diarrea.
- Botulismo: parálisis descendente rápidamente progresiva (comienza afectando a pares craneales y progresa a brazos y piernas) asociada a síntomas de disfunción autonómica (retención urinaria, íleo, dificultad de respuesta pupilar a la luz). Producida por la toxina del *Clostridium botulinum* que inhibe la liberación de la acetilcolina en las terminaciones nerviosas periféricas a nivel presináptico, se produce al ingerir alimentos contaminados generalmente conservas, después de ingerido la clínica comienza entre las 12 -48h con dolor abdominal, náuseas y vómitos, posteriormente aparecen los síntomas: 1. anticolinérgicos como xerostomía, oftalmoplejía, midriasis arreactiva, visión borrosa por alteración de la acomodación. 2. Motores como la parálisis flácida descendente y simétrica, ptosis, diplopía, disfagia. La debilidad de la musculatura es precoz, y descendente, desde craneal a caudal, al contrario que en el Síndrome de Guillain-Barré. Finalmente, la debilidad se generaliza y produce una insuficiencia respiratoria. El tratamiento comprende medidas de soporte y mantenimiento hidroelectrolítico y adultos: antitoxina botulínica (antitoxina bivalente A-B equina, un vial, 250 ml IV). Niños no se emplea la antitoxina equina, administrar Ig humana antitoxina botulínica (50 mg/kg en dosis única, administrada en los 7 días siguientes al comienzo de la clínica).

TRATAMIENTO

- Ingreso en UCI: vigilancia respiratoria, manejo de secreciones, IOT y ventilación mecánica si precisa.
- Tratamiento de la causa subyacente.
- Bajar dosis de anticolinesterásicos: puede haber cierta resistencia a su efecto en una crisis miasténica, además aumentan las secreciones respiratorias. Conviene reducir la dosis y aumentarla pasados unos días, lentamente según respuesta individual.
- Inmunoterapia:
 - o Administración endovenosa de inmunoglobulinas a dosis 0,4 g/Kg/24h durante 5 días. ¡Ojo! Comprobar que no existe déficit de IgA previamente, pueden tener una reacción anafiláctica.
 - Otros efectos adversos: dermatitis, infecciones, edema pulmonar, trombosis venosa, meningitis aséptica, hemólisis.
 - Contraindicadas en: estados de hipercoagulabilidad, fallo renal, hipersensibilidad a las inmunoglobulinas.
 - o Plasmaféresis: evitar en sepsis.
 - o Inmunoabsorción.
- Posteriormente pauta ascendente de corticoides y ajuste de tratamiento inmunosupresor (ver apartado miastenia gravis -Tratamiento).

Algoritmo de manejo



BIBLIOGRAFÍA

- Illa I, Olivé M, Jáuregui A, Bárcena J, et al. Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Neurología, de J.J. Zarranz. 6ª Edición. Elsevier; 2018. 625-657.
- Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepulveda JM. Urgencias en neurología. Hospital Universitario 12 de Octubre. 2.ª edición. Madrid: Ergon; 2013.
- Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: executive summary. Neurology. 2016;87:419-425.
- Rabinstein AA. Acute neuromuscular respiratory failure. Continuum (Minneap Minn). 2015;21:1324-1345.
- Melzer N, Ruck T, Fuhr P, Gold R, et al. Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: A supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. J Neurol. 2016;263:1473-1494.
- Ciafaloni E. Myasthenia Gravis and Congenital Myasthenic Syndromes. Continuum (Minneap Minn). 2019 Dec;25(6):1767-1784.